

Il Prossimo Capitolo: Da TS a Soccorritore Esecutore

Ruolo, Responsabilità e la Gestione del Paziente Traumatizzato



L'Inizio di un Nuovo Viaggio

Siamo Nicolò e Alessandra. Come voi, siamo volontari in Croce Verde Baggio e oggi, nel nostro ruolo di Istruttori certificati AREU (si pronuncia Aréu), siamo qui per accompagnarvi nel passo successivo del vostro percorso.

Innanzitutto, complimenti. Aver completato il corso da Trasporto Sanitario (TS) è il primo, fondamentale traguardo. Avete costruito le fondamenta.

Ora, con il corso da Soccorritore Sanitario Esecutore (SSE), non aggiungeremo solo nozioni. Cambieremo prospettiva. Passerete da 'trasportare' un paziente a 'soccorrere' una persona in un contesto di emergenza-urgenza. È una sfida più grande, ma anche la soddisfazione di poter fare davvero la differenza.



La Nostra Mappa per Oggi

In questa lezione affronteremo quattro tappe fondamentali per il vostro nuovo ruolo:

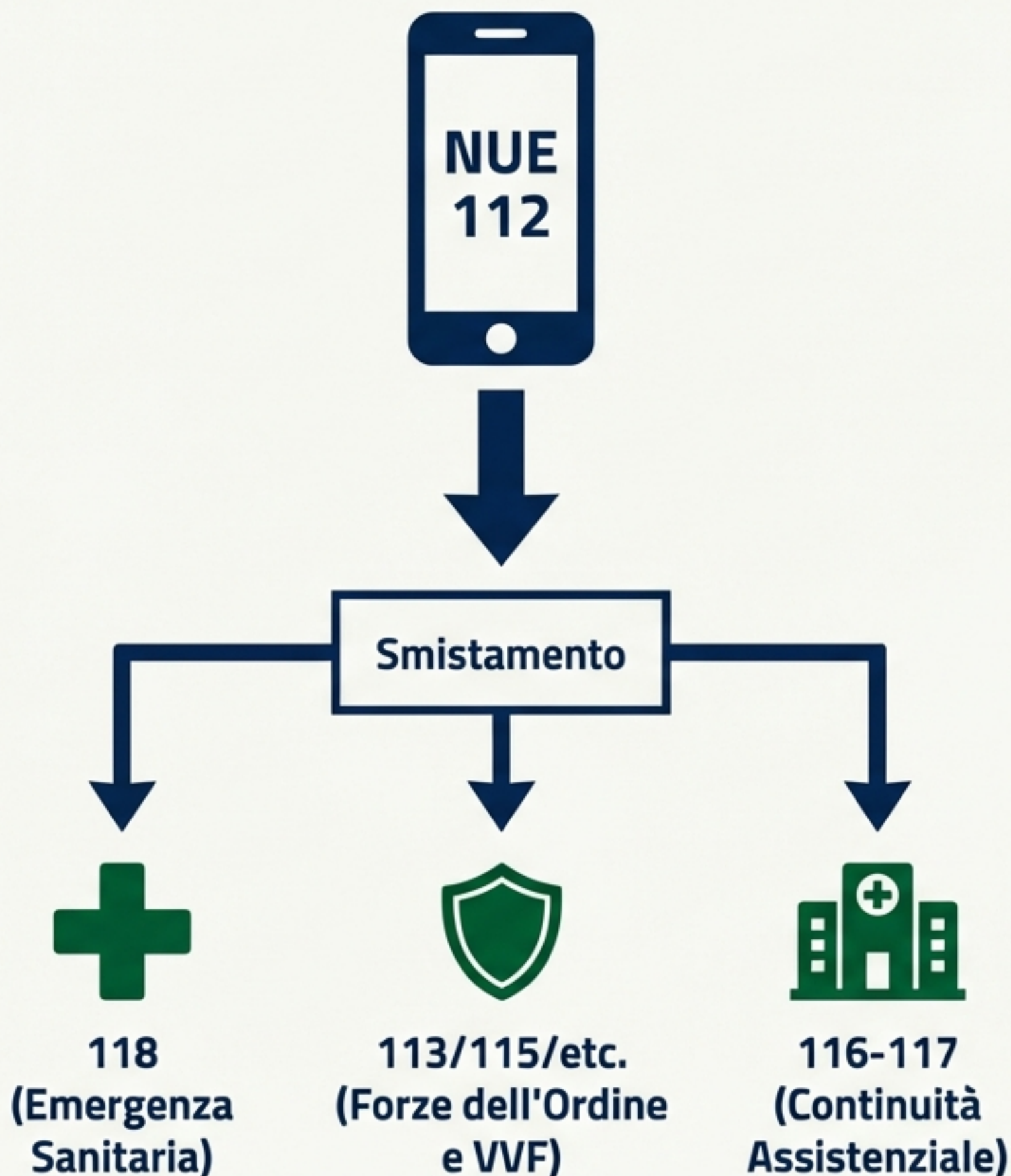
- 1**  **Il Salto di Qualità: Ruolo e Regolamento SSE**
Cosa cambia davvero rispetto al ruolo di TS e come ci si inserisce nel Sistema di Emergenza.
- 2**  **La Responsabilità non è un'Opzione**
Gli aspetti legali ed etici che definiscono la nostra professionalità.
- 3**  **Una Nuova Sfida: Il Paziente Traumatizzato**
Perché il trauma è un “mondo” a parte e richiede un approccio specifico.
- 4**  **I Primi Passi sulla Scena**
La valutazione della scena: la vostra prima e più importante manovra di autoprotezione.

Il Salto di Qualità: Da TS a SSE

Il passaggio da TS a SSE è un cambio di paradigma. Il vostro ruolo precedente era la base fondamentale per arrivare qui.

Trasporto Sanitario (TS)	Soccorritore Sanitario Esecutore (SSE)
Attivazione: Programmata o su richiesta.	Attivazione: Sempre ed esclusivamente dalla SOREU (Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza) via 118.
Obiettivo: Trasportare in sicurezza un paziente stabile che necessita di monitoraggio di base.	Obiettivo: Intervenire su un evento acuto, valutare, stabilizzare e trattare un paziente critico sul territorio.
Ruolo: Eseguire un trasporto assistito.	Ruolo: Essere il primo anello medicalizzato (di base) della catena del soccorso in emergenza-urgenza.

Bottom line: Come SSE, siete gli occhi e le mani della SOREU sulla scena. La vostra valutazione determina le azioni successive e, spesso, l'esito per il paziente.



Il Vostro 'Quartier Generale': Il Sistema AREU

Ogni nostro intervento nasce da una chiamata al **NUE 112**. Un operatore "laico" filtra la chiamata e la smista alla centrale competente.

Le emergenze sanitarie arrivano alla **SOREU (118)**, il nostro diretto referente. Ce ne sono 4 in Lombardia (Alpina, dei Laghi, Metropolitana, della Pianura) e sono il cervello del sistema.

Il vostro ruolo come SSE:

- Siete attivati esclusivamente dalla SOREU.
- Comunicate con la SOREU per descrivere la scena, il paziente e chiedere supporto (es. auto medica).
- Trasportate il paziente all'ospedale indicato dalla SOREU (spesso un 'Hub' specialistico per patologie come trauma o ictus).

Non siete mai soli, ma siete un terminale attivo e pensante di questa rete.

La Squadra in Campo: I Mezzi di Soccorso

Sulla scena non sarete quasi mai l'unico mezzo. È fondamentale conoscere i diversi livelli di soccorso per interagire correttamente.



MSB - Mezzo di Soccorso di Base

- **Equipaggio:** Autista + 2 Soccorritori Esecutori (SSE). **Questo siete voi.**
- **Funzione:** Primo intervento, valutazione, manovre di base (BLSD, immobilizzazione, medicazioni).



MSI - Mezzo di Soccorso Intermedio

- **Equipaggio:** Autista + Soccorritore + **Infermiere.**
- **Funzione:** Gestione avanzata del paziente (accessi venosi, farmaci su protocollo).



MSA - Mezzo di Soccorso Avanzato

- **Equipaggio:** Autista + Soccorritore + **Infermiere + Medico.**
- **Funzione:** Massima capacità di trattamento sul posto, manovre invasive.

Il vostro compito è fornire al team più avanzato un paziente già valutato e stabilizzato al meglio delle vostre possibilità.



La Responsabilità Inizia Qui

"Indossare questa divisa significa assumersi un carico di responsabilità legali, etiche e personali. Non è solo ciò che fate, ma come e perché lo fate a definirvi come professionisti del soccorso."

Come Soccorritori Esecutori siete **Incaricati di Pubblico Servizio**. Questo status giuridico vi conferisce tutele, ma soprattutto **doveri** molto precisi.

"Ignorantia legis non excusat"
(L'ignoranza della legge non è una scusa)

Tra Codice e Coscienza: I Vostri Doveri



Responsabilità Legale

- **Guida Sicura:** L'autista è responsabile a meno che non dimostri di *"aver fatto tutto il possibile per evitarlo"* (Art. 2054 C.C.). Sirene e lampeggianti non vi danno l'immunità.
- **Pubblico Servizio:** Le vostre parole e azioni hanno un peso legale. Una relazione di servizio non veritiera può avere conseguenze gravi.
- **Omissione di Soccorso:** L'unica eccezione è **un pericolo reale e attuale** per la vostra incolumità (es. scena violenta).



Responsabilità Etica & Professionale

- **Segreto Professionale e d'Ufficio:** Tutto ciò che vedete e sentite in servizio DEVE rimanere in servizio. La violazione è un **reato penale** (Art. 622 e 326 C.P.).
- **Privacy:** Trattate le informazioni sanitarie con il massimo riserbo. Il paziente vi affida i suoi dati più sensibili (GDPR, D.Lgs 196/2003).
- **Consenso Informato:** Spiegate sempre al paziente cosciente cosa state per fare. Questo riduce la paura e costruisce fiducia.

La Responsabilità Inizia Prima della Chiamata

La vostra più grande responsabilità non è sul luogo dell'evento, ma scatta nel momento in cui mettete piede in sede. **Il controllo del mezzo e dei presidi** (si pronuncia presidi, non présidi) è un vostro dovere preciso e non delegabile.

- ✓ Zaini completi e in ordine?
- ✓ Bombola d'ossigeno carica?
- ✓ Aspiratore funzionante?
- ✓ **Defibrillatore carico? Placche non scadute?**

“Arrivare su un intervento e scoprire che il DAE ha la batteria scarica non è sfortuna, è un nostro fallimento. E non ce lo possiamo permettere.”



La Prossima Sfida: Il Paziente Traumatizzato

Fino ad ora abbiamo ripassato le fondamenta del vostro ruolo. Adesso, apriamo la porta su uno degli argomenti più complessi e cruciali per un SSE: **la gestione del trauma.**

Il trauma non è una malattia. È una lesione fisica, spesso violenta e improvvisa, causata da un'energia esterna. È la **prima causa di morte** negli individui al di sotto dei 40 anni.

Il vostro approccio a questo tipo di paziente deve essere **rapido, sistematico e spietatamente logico.** Il protocollo, come il PHTLS che imparerete, è la vostra unica guida. L'improvvisazione non è un'opzione.

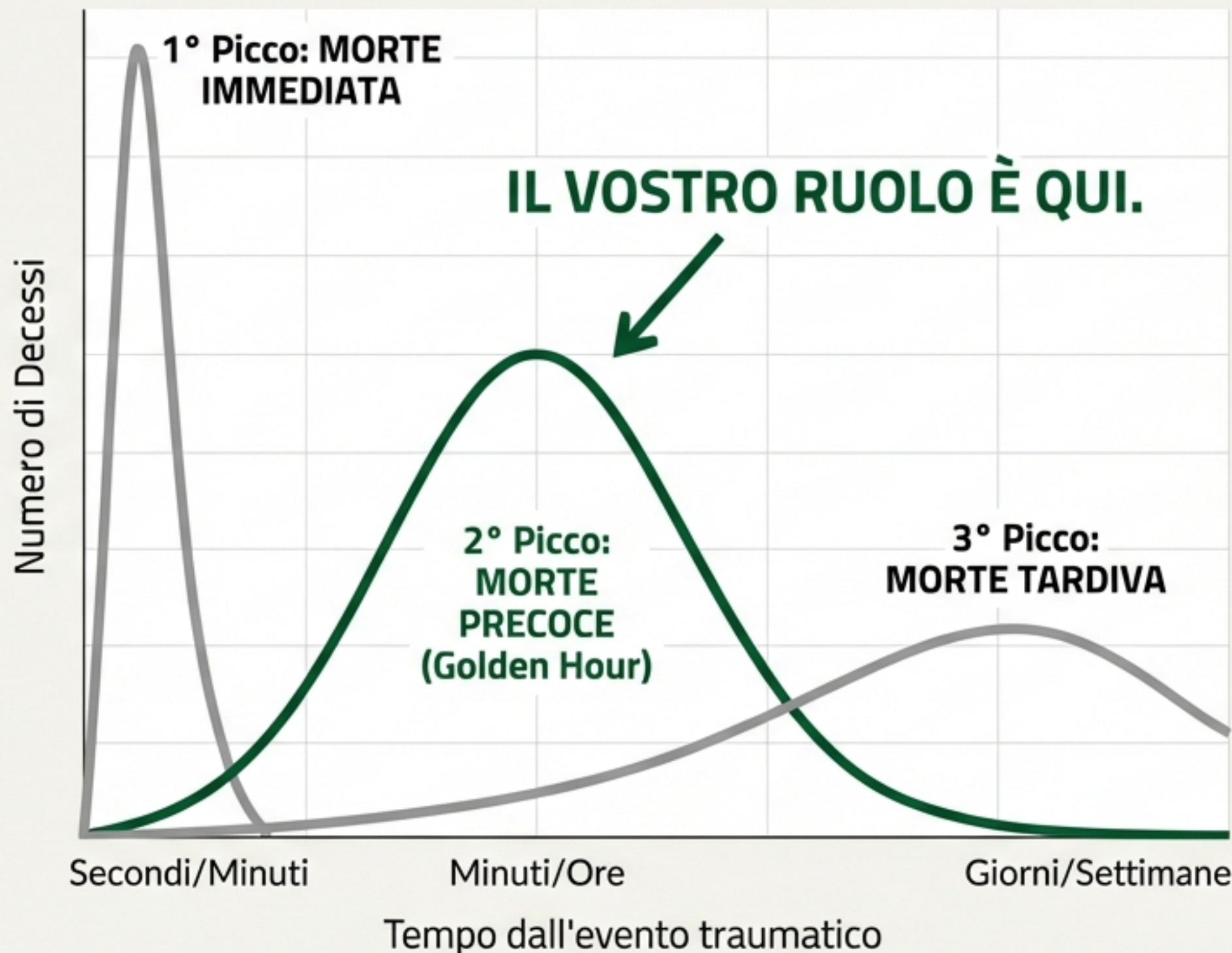
Il Trauma: Una Corsa Contro il Tempo

La mortalità nel trauma segue una distribuzione "trimodale". Capirla significa capire perché il vostro ruolo è vitale.

1° Picco (Secondi/Minuti):

Lesioni devastanti (es. rottura del cuore, lesioni cerebrali massive).

Il nostro ruolo: Nessuno. Solo la prevenzione (cinture, casco) agisce qui.



3° Picco (Giorni/Settimane):

Complicanze in ospedale (es. sepsi, insufficienza multiorgano). **Il nostro ruolo:** Aver portato il paziente nel posto giusto (Trauma Center) e nelle migliori condizioni possibili.

2° Picco (Minuti/"Golden Hour"): Lesioni potenzialmente letali (es. emorragie massive, pneumotorace, ematomi cerebrali). Un soccorso rapido e corretto può cambiare radicalmente il destino del paziente.



L'Approccio al Trauma: La Prima Manovra è Guardare

Nel paziente traumatizzato, la prima e più importante azione non si compie sul paziente, ma **attorno** ad esso. Si chiama **valutazione della scena**.

- 1. SICUREZZA:** Garantire l'incolumità dell'equipaggio, del paziente e di eventuali astanti.
Un soccorritore ferito è un soccorritore inutile, anzi, è un secondo paziente.
- 2. SITUAZIONE:** Capire **cosa è successo** (meccanismo di lesione) e di quali risorse abbiamo bisogno.
- 3. SOCCORSO:** Solo dopo aver garantito i primi due punti, si inizia la valutazione del paziente.

Il principio del PHTLS (Prehospital Trauma Life Support) è chiaro: la **sicurezza della squadra viene prima di tutto**.

La Scena: Sicurezza e Indizi (ABC della Scena)

Una valutazione strutturata della scena risponde a domande precise. Usate questo schema mentale:

A

Autoprotezione e pericoli



- C'è traffico? Fuoco? Fili elettrici? Odore di gas? Scena violenta?
- **Azione:** Indossare i DPI, posizionare l'ambulanza per proteggere la scena, allertare VVF o FF00 se necessario.

B

Bilancio dell'evento



- **Meccanismo di lesione:** Cosa è successo? Auto contro muro? Caduta dall'alto? Questo ci dà l'**indice di sospetto** sulle possibili lesioni.
- **Numero di pazienti:** Quanti sono?

C

Chiamata alla SOREU e coordinamento



- **Azione:** Comunicare alla SOREU un quadro chiaro e sintetico per permettere l'invio delle risorse adeguate.



CRIME SCENE - DO NOT CROSS

Caso Particolare: La Scena del Crimine

In caso di aggressioni o qualsiasi situazione sospetta, la scena non è solo un luogo di cura, ma anche una **fonte di prova**. La nostra priorità resta il paziente, ma dobbiamo agire con cautela per non inquinare le prove.

Regole d'oro:

- Entrate e uscite da un unico percorso.
- **Toccate solo lo stretto indispensabile** per soccorrere la vittima.
- **Non spostate oggetti o armi**, a meno che non costituiscano un pericolo immediato.
- **Conservate gli indumenti** che rimuovete e consegnateli alle Forze dell'Ordine.
- **Usate guanti puliti** e a fine soccorso rimuovete tutto il vostro materiale.

Collaborare con le Forze dell'Ordine è parte integrante del nostro ruolo.

Pronti per il Viaggio?

Oggi abbiamo visto che diventare Soccorritore Esecutore è molto più di un corso:

- È un **salto di responsabilità**, che vi pone in prima linea nel sistema di emergenza.
- È un **impegno legale ed etico** che richiede integrità e professionalità costanti.
- È l'inizio di una nuova sfida clinica, quella contro il **tempo e il trauma**.
- Inizia sempre con un'azione semplice ma vitale: **garantire la sicurezza della scena**.

Questo percorso è impegnativo. Vi chiederà studio, pratica e dedizione. Ma alla fine, vi darà gli strumenti per fare, davvero, la differenza.

In bocca al lupo, futuri colleghi.

